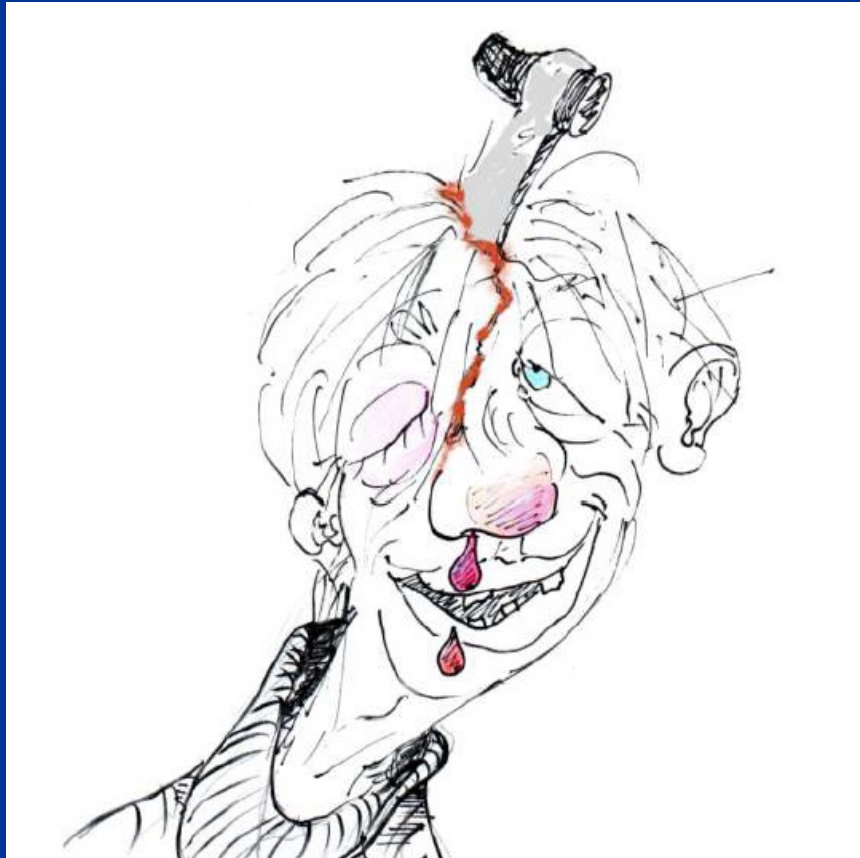


LES TRAUMATISMES MAXILLO-FACIAUX



Pr D. Kamal
Service de Chirurgie
Réparatrice et Maxillo-
faciale

PLAN

- I. Introduction
- II. Gestes d'urgence
- III. Bilan
- IV. Classification
- V. Traitement
- VI. Conclusion

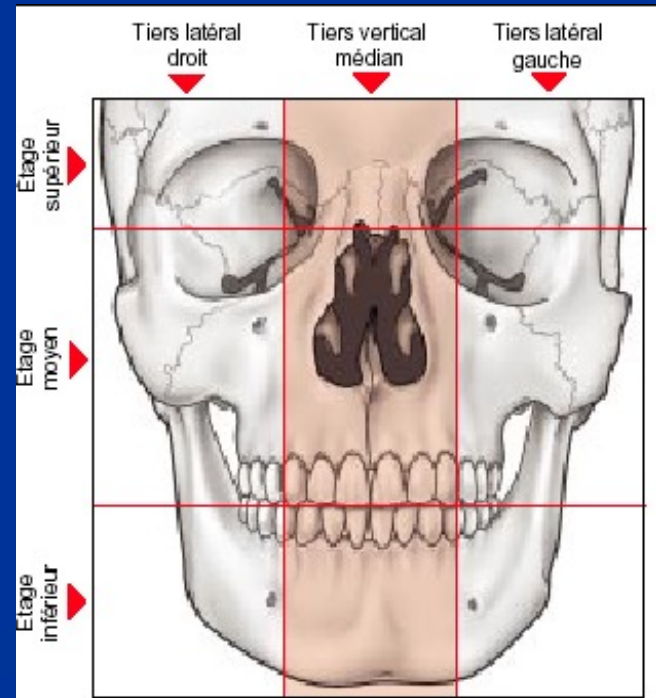
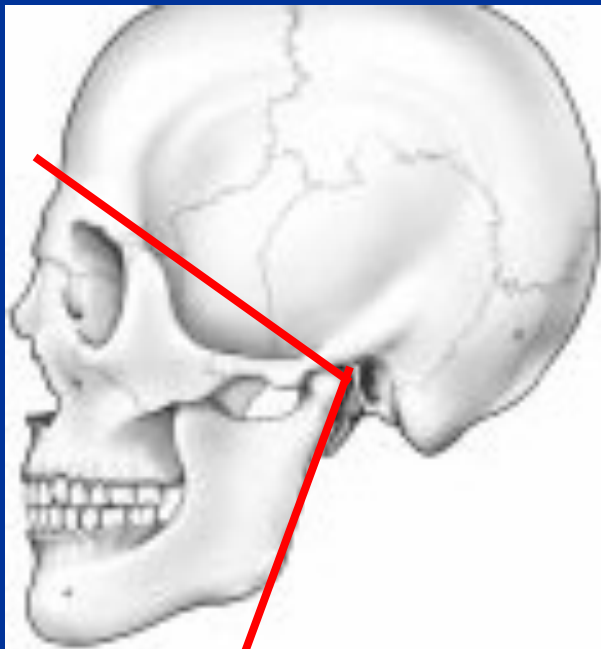
I. INTRODUCTION

■ Définition

Ensemble des lésions de nature traumatique

Partie antérieure de l'extrémité céphalique

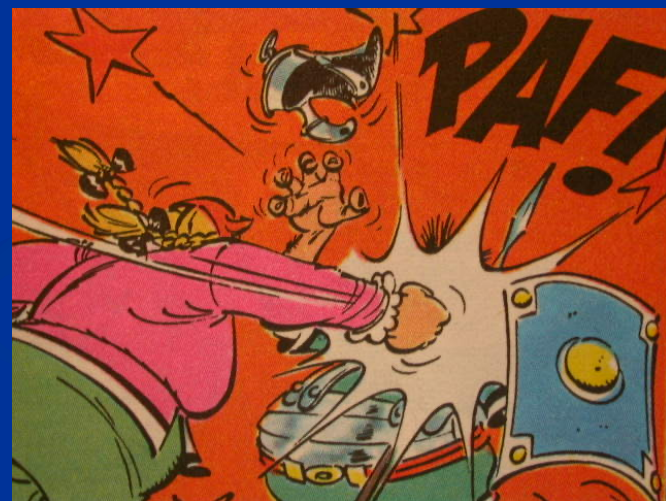
Stade de l'urgence sur le terrain et à l'hôpital lors du traitement primaire



Sectorisation de la face selon Pons

I. INTRODUCTION

- Traumatologie face = 15 à 20% des traumatismes
- Etiologies :
 - AVP
 - Accident de travail
 - Accident de sport
 - Rixes
- Sujet jeune = 20 et 30 ans



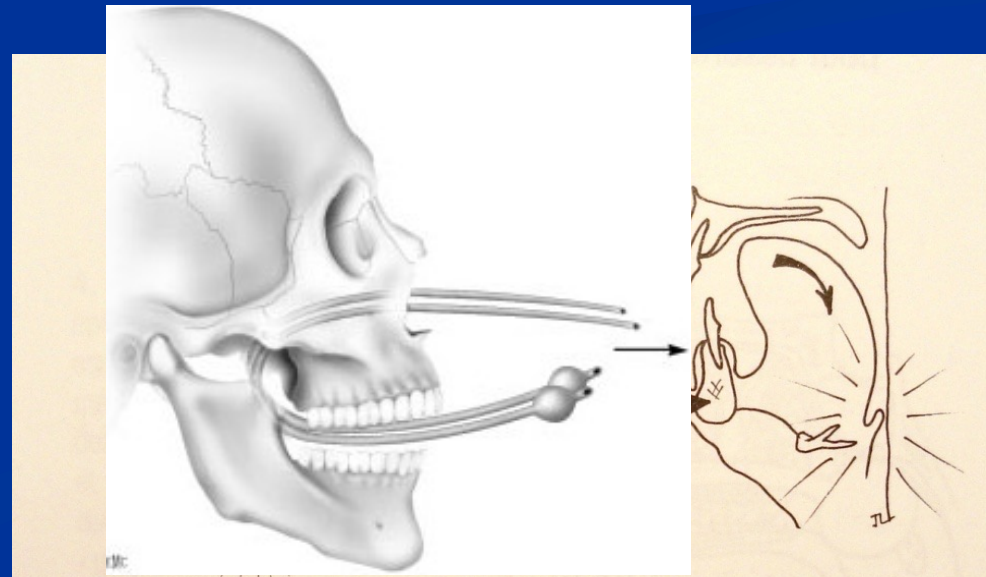
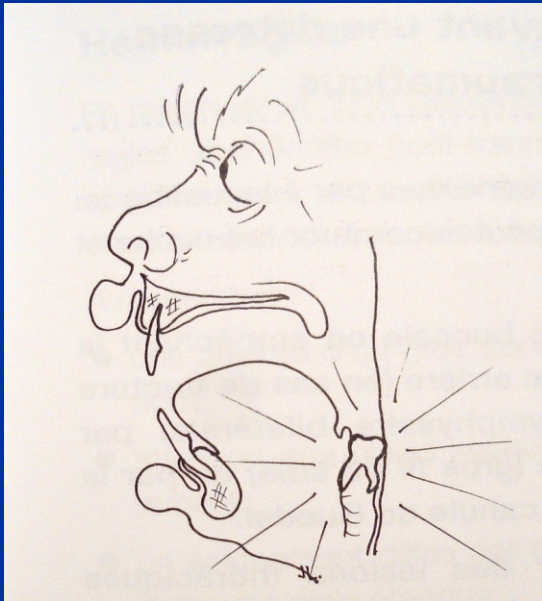
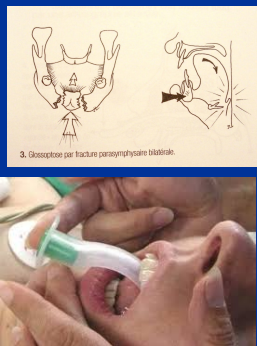
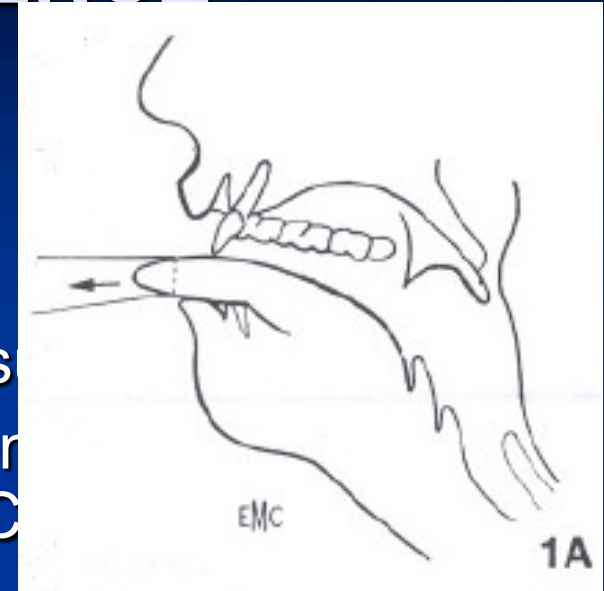
GESTES D'URGENCE

1. Assurer la liberté des VAS
2. Contrôler l'hémorragie
3. Stabiliser le rachis cervical
4. Rechercher les lésions associées
5. Prévenir l'infection
6. Lutter contre la douleur et le froid

GESTES D'URGENCE

1. Assurer la liberté des VAS

- Décubitus latéral
- Désobstruer la filière aérienne supérieure
- Maintenir l'ouverture buccale en cas de chute de la langue en arrière : C



Troubles asphyxiques

■ Causes locales :

- Caillots sanguins
- Corps étranger
- Dislocation pyramide nasale
- Hématome (langue, plancher, palais mou)
- Glossoptose
- Recul massif facial
- Œdème (brûlures de la face)

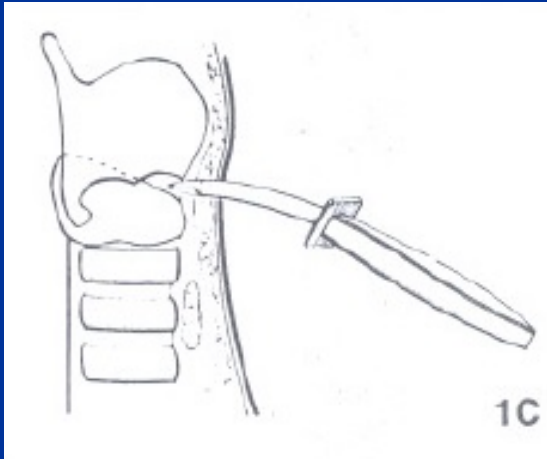
■ Cause extra-faciale :

Centrale (centres respiratoires) ou Périphérique (atteinte thoracique, pariétale ou parenchymateuse)

II. GESTES D'URGENCE

1. Assurer la liberté des VAS

- Intubation trachéale
- Coniotomie = laryngotomie inter cricothyroïdienne



II. GESTES D'URGENCE

1. Assurer la liberté des VAS

- Trachéotomie : intubation impossible, traumatisme laryngé ouvert, grand délabrement maxillo-facial



II. GESTES D'URGENCE

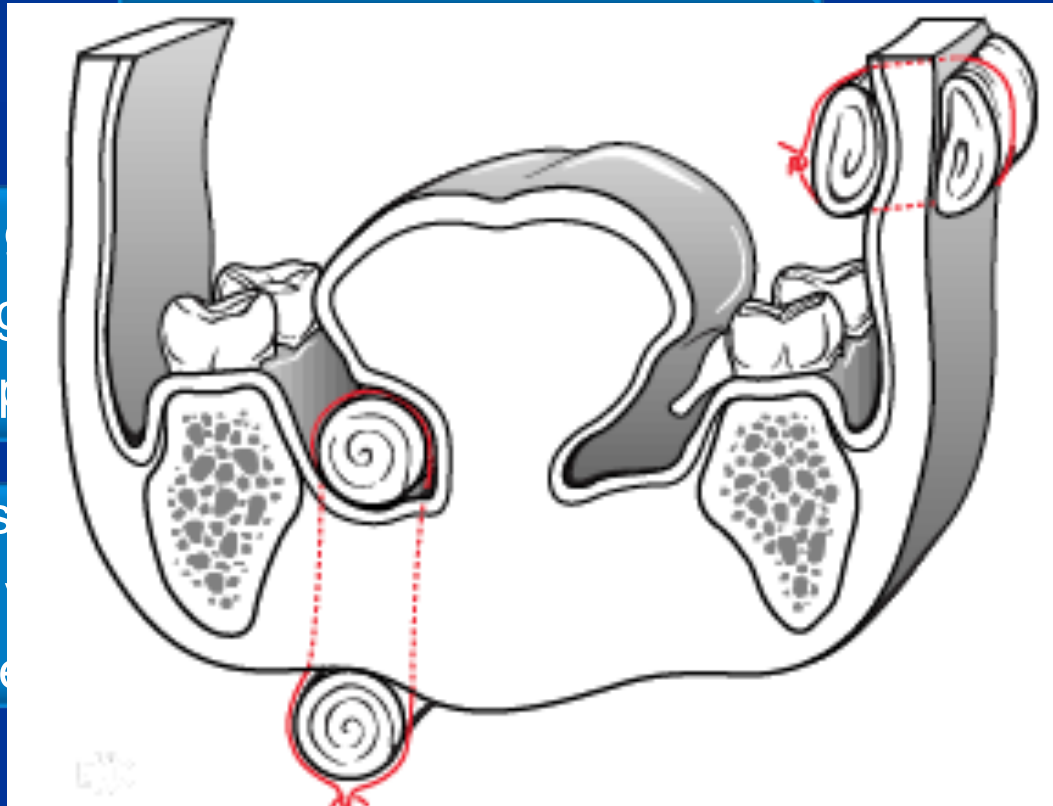
2. Contrôler l'hémorragie

QE!!

- Évaluation de la gravité
- Réanimation

- Atteinte d'un
- Saignement g
- Plaie du scalp

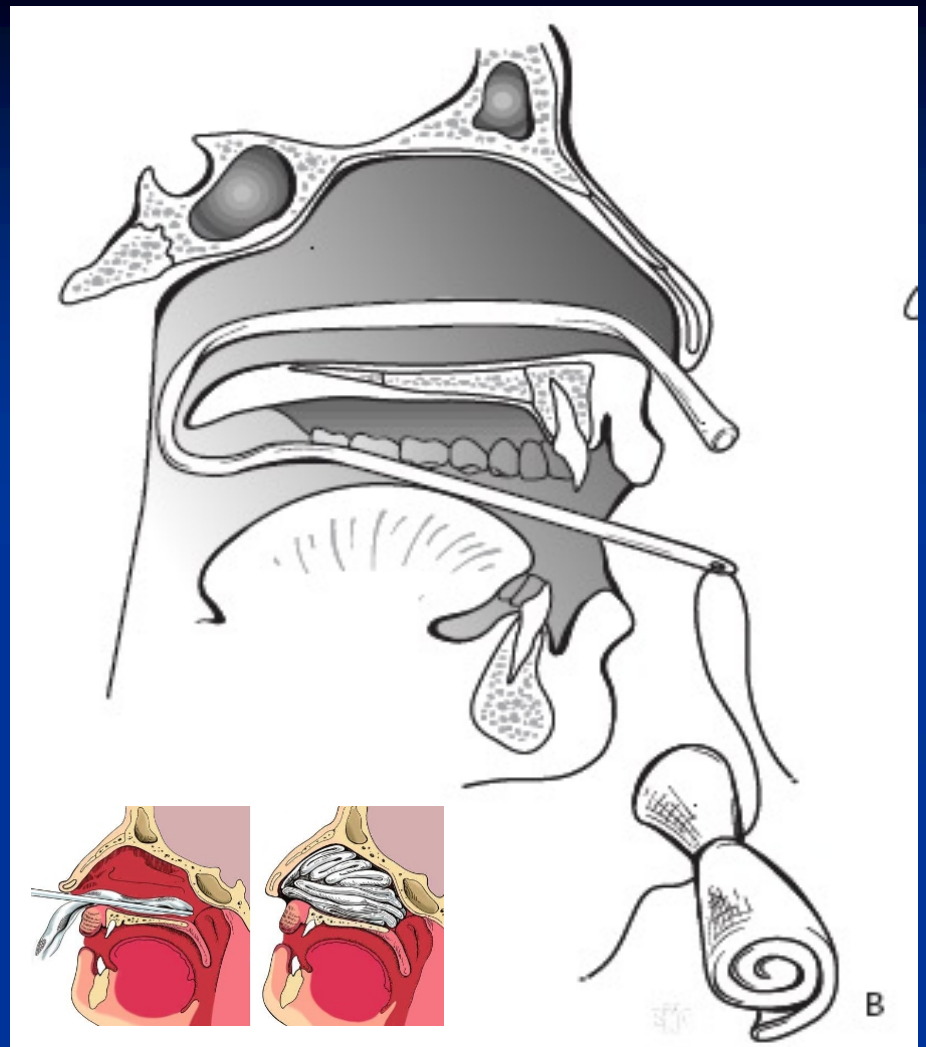
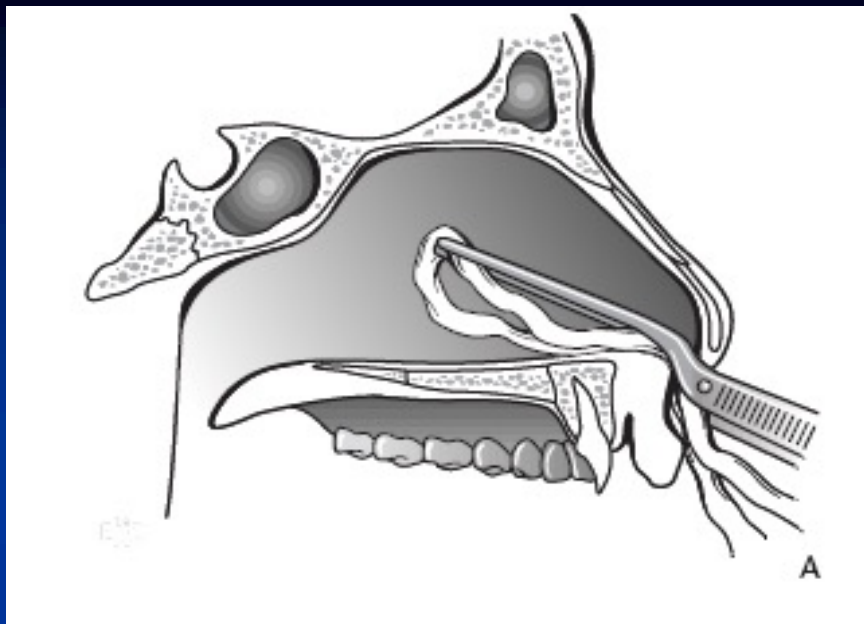
- Compres
- Ligature
- Suture de



ère

antérieure

postérieure



A. Tamponnement nasal antérieur.
B. Tamponnement nasal postérieur
C. Tamponnement nasal mixte.

II. GESTES D'URGENCE

2. Contrôler l'hémorragie

QE!!



- Évaluation de la gravité
- Réanimation



- Atteinte d'un gros tronc vasculaire
- Saignement généralisé
- Plaie du scalp

- Compression manuelle
- Ligature vasculaire
- Suture des plaies

Épistaxis sévère



- Méchage antérieure
- +/- méchage postérieur



Artériographie + embolisation

II. GESTES D'URGENCE

3. Stabiliser le rachis cervical

4. Rechercher les lésions associées

☐ Neurochirurgicales 

☐ Ophtalmologiques

5. Prévenir l'infection 

6. Lutter contre la douleur et le froid

II. GESTES D'URGENCE

- 1. Assurer la liberté des VAS**
- 2. Contrôler l'hémorragie**
- 3. Stabiliser le rachis cervical**
- 4. Rechercher les lésions associées**
- 5. Prévenir l'infection**
- 6. Lutter contre la douleur et le froid**

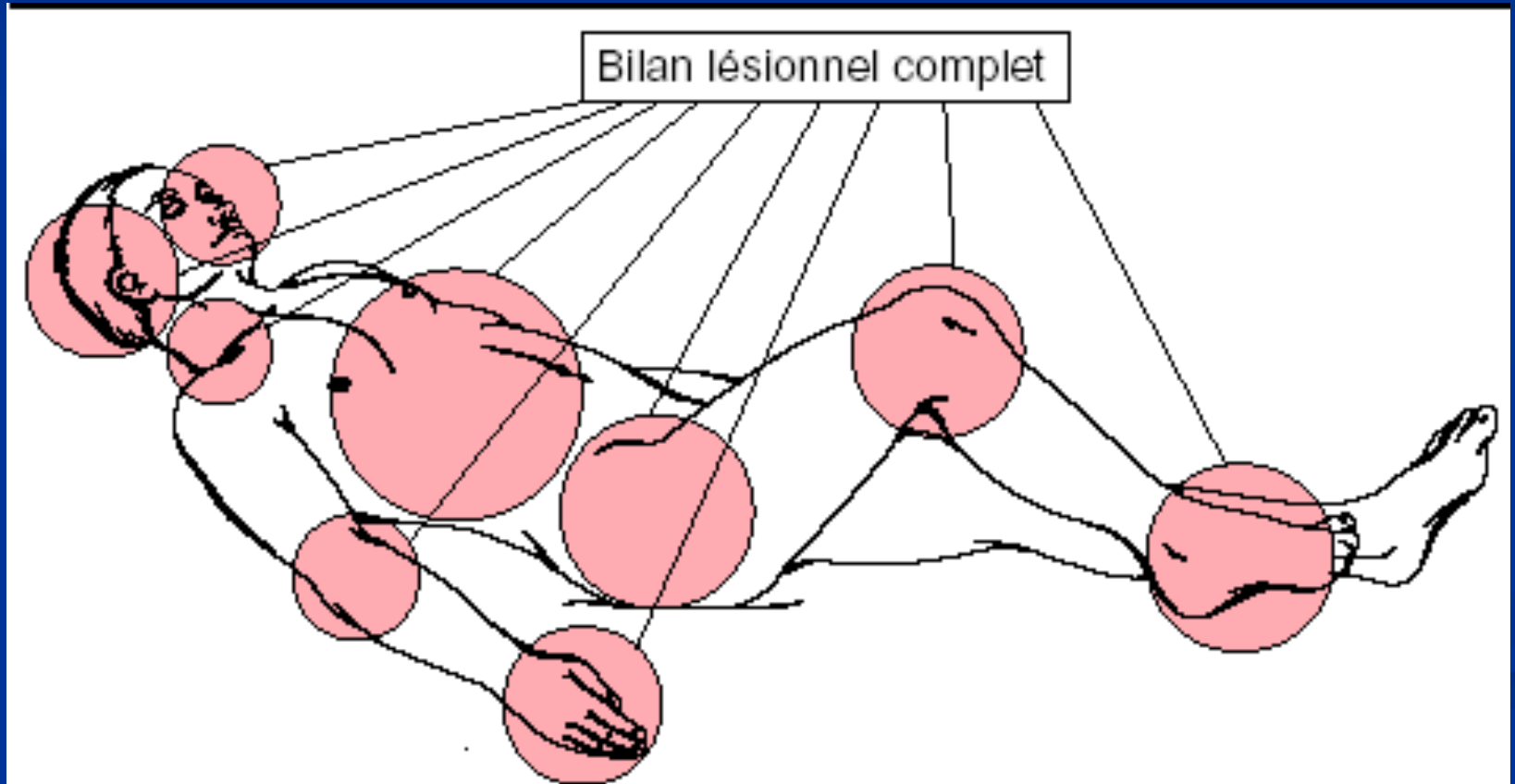
III. BILAN

1) Interrogatoire

- Âge du patient
- Horaire, lieu, circonstances de l' accident
- Heure du dernier repas
- Notion de perte de connaissance initiale
- Antécédents
- Signes fonctionnelles: douleur, trismus, BAV, diplopie, anosmie, hypoesthésie, trouble de l'articulé dentaire...
- Photos

III. BILAN

2) Examen général



III. BILAN

3) Examen local

a. Examen maxillo-facial

➤ Examen exobuccal

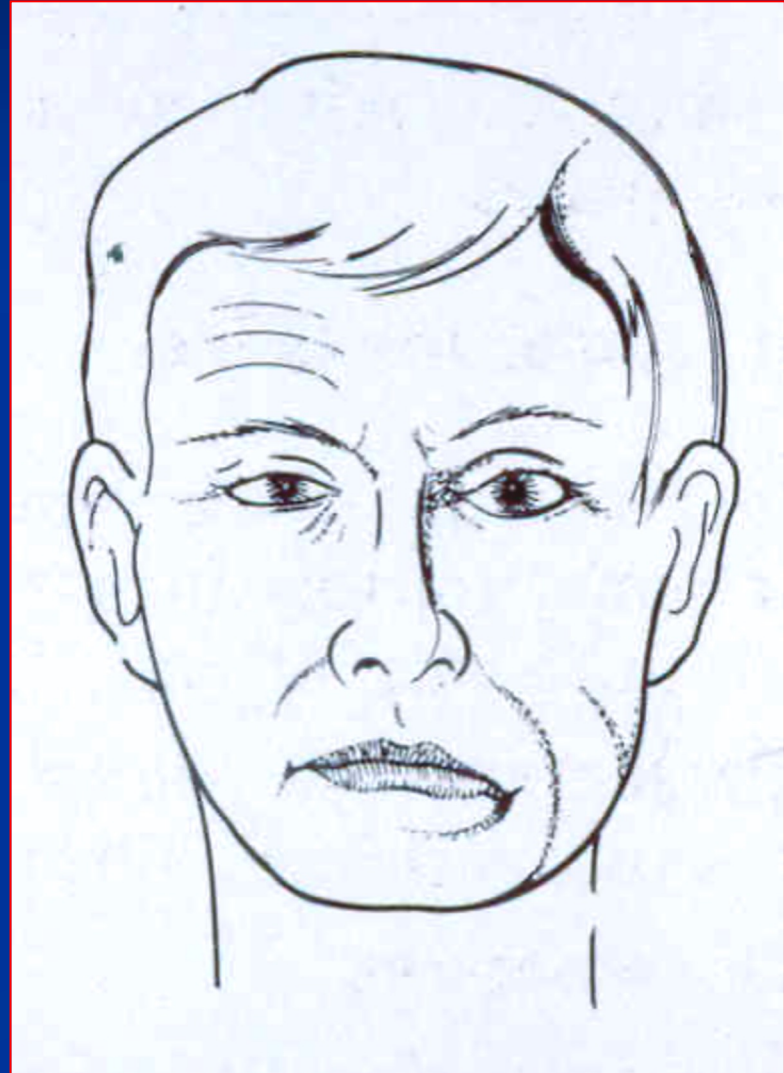
→ Inspection statique

- États de téguments
- Déformations
- Écoulements de sang ou de LCR



Test de la motricité

→ Inspection dynamique
→ Nerf facial



III. BILAN

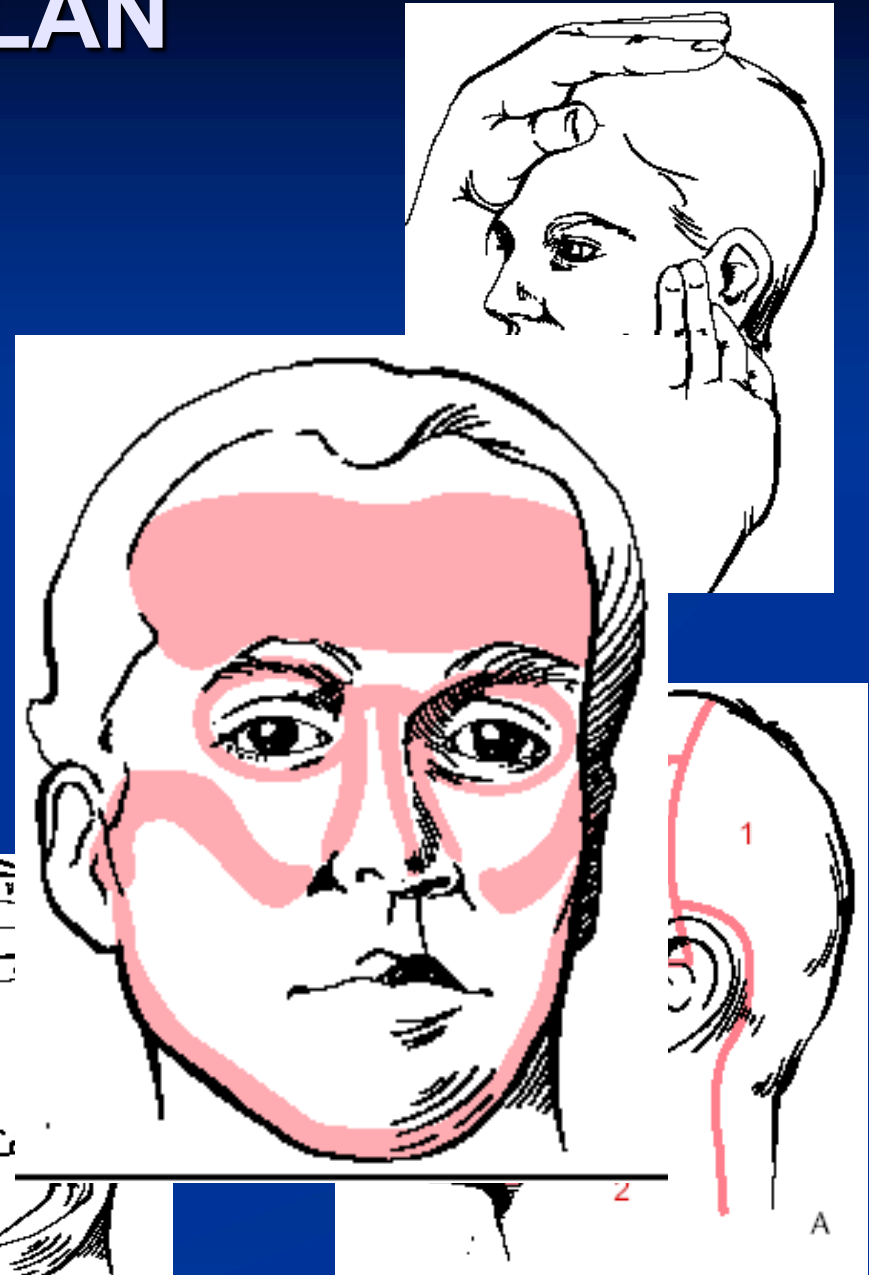
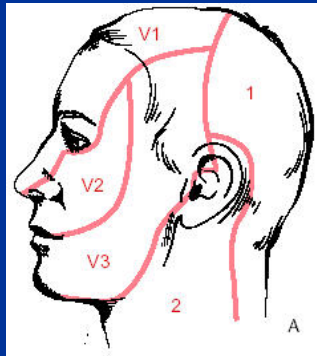
3) Examen local

a. Examen maxillo-facial

➤ Examen exobuccal

→ Palpation

- Emphysème sous-cutané,
- Points douloureux,
- Déformation osseuse,
- Mobilité,
- Sensibilité
- Manœuvres dynamiques

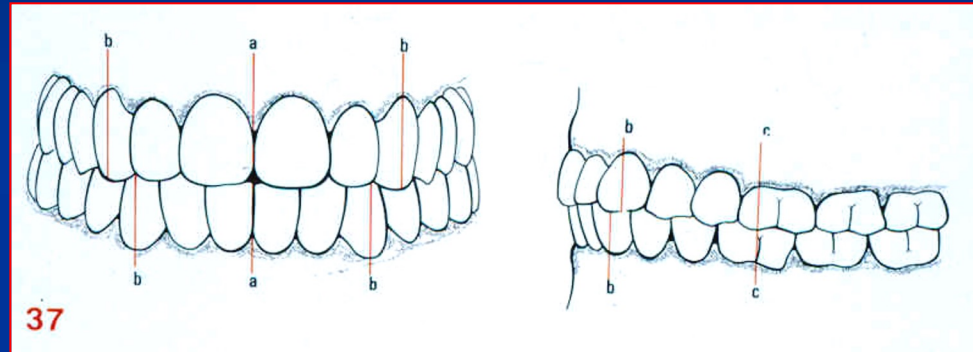


III. BILAN

3) Examen local

a. Examen maxillo-facial

- Examen endobuccal
 - Inspection
 - Anomalie de l'articulé dentaire
 - Ouverture buccale
 - État de la muqueuse
 - Examen dentaire et parodontal



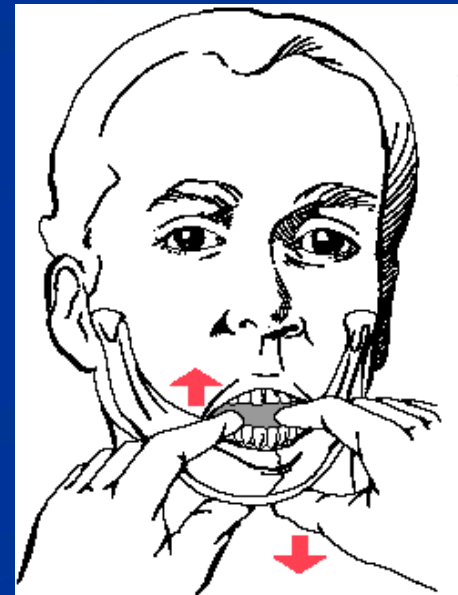
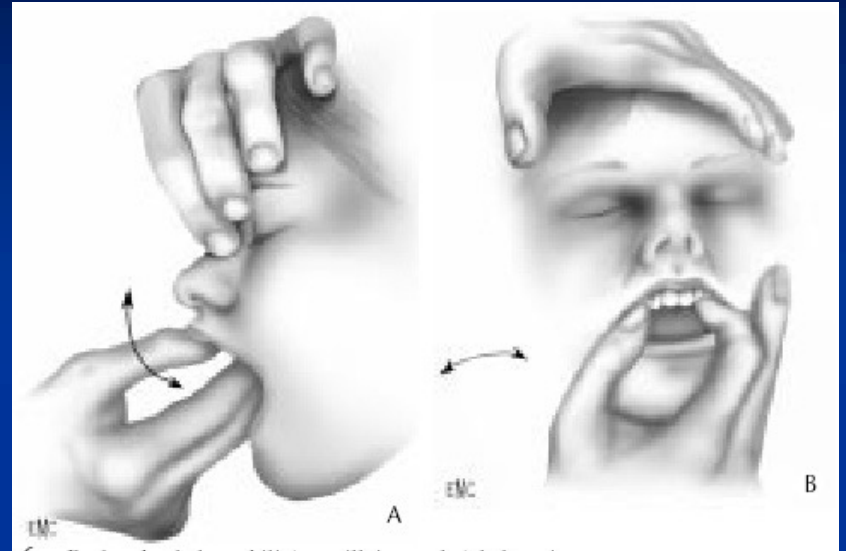
III. BILAN

3) Examen local

a. Examen maxillo-facial

➤ Examen endobuccal

- Palpation
 - Douleur
 - Mobilité

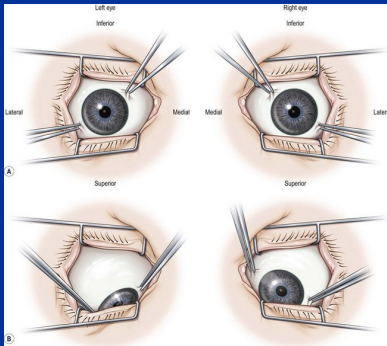
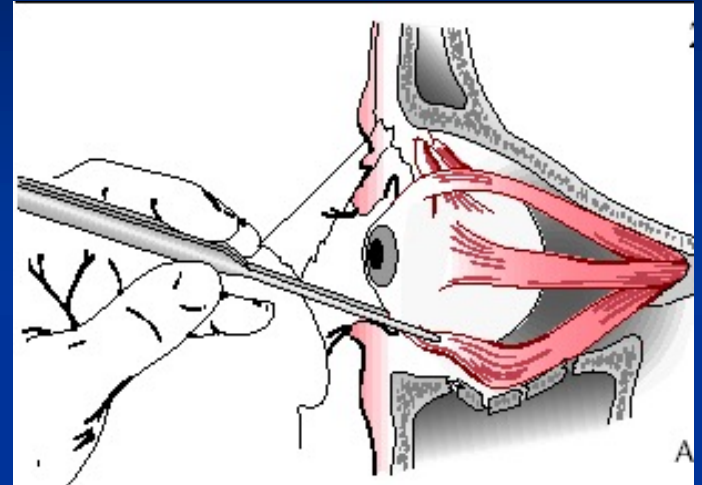
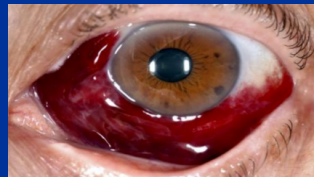


III. BILAN

3) Examen local

b. Examen de l'œil

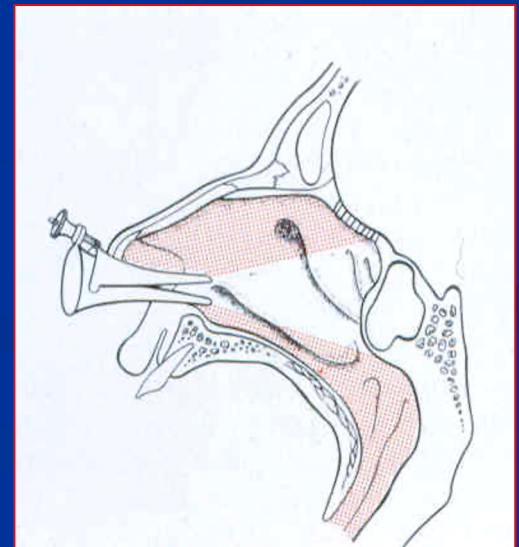
- Plaie pénétrante du globe
 - Exophtalmie
 - Hémorragie sous conjonctivale
 - Statique du globe
 - Dynamique oculaire
- Test de Duction forcée



III. BILAN

3) Examen local

- c. Examen du conduit auditif externe
- d. Examen du nez

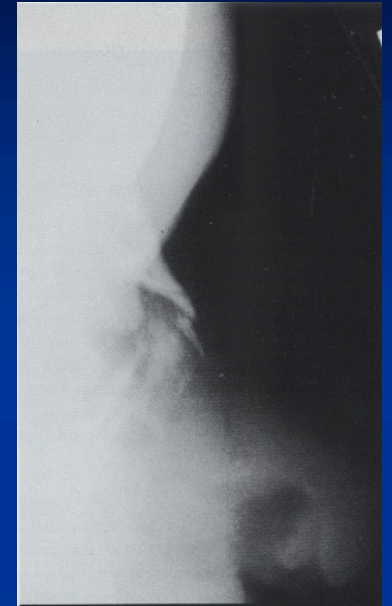
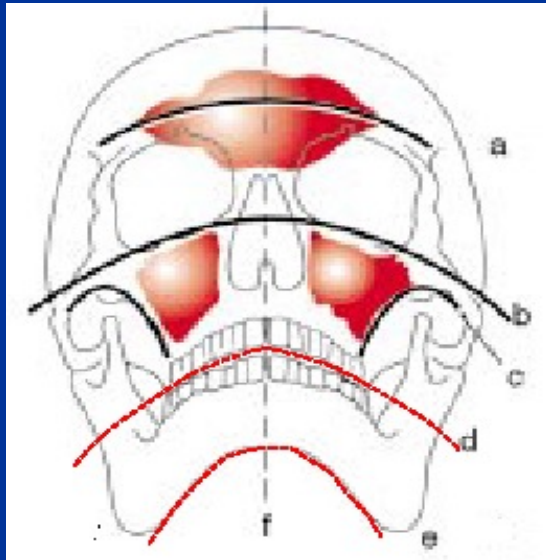


III. BILAN

4) Examens complémentaires

a. Radiographies standards

1. Radiographie Blondeau
2. Radiographie des os nasaux

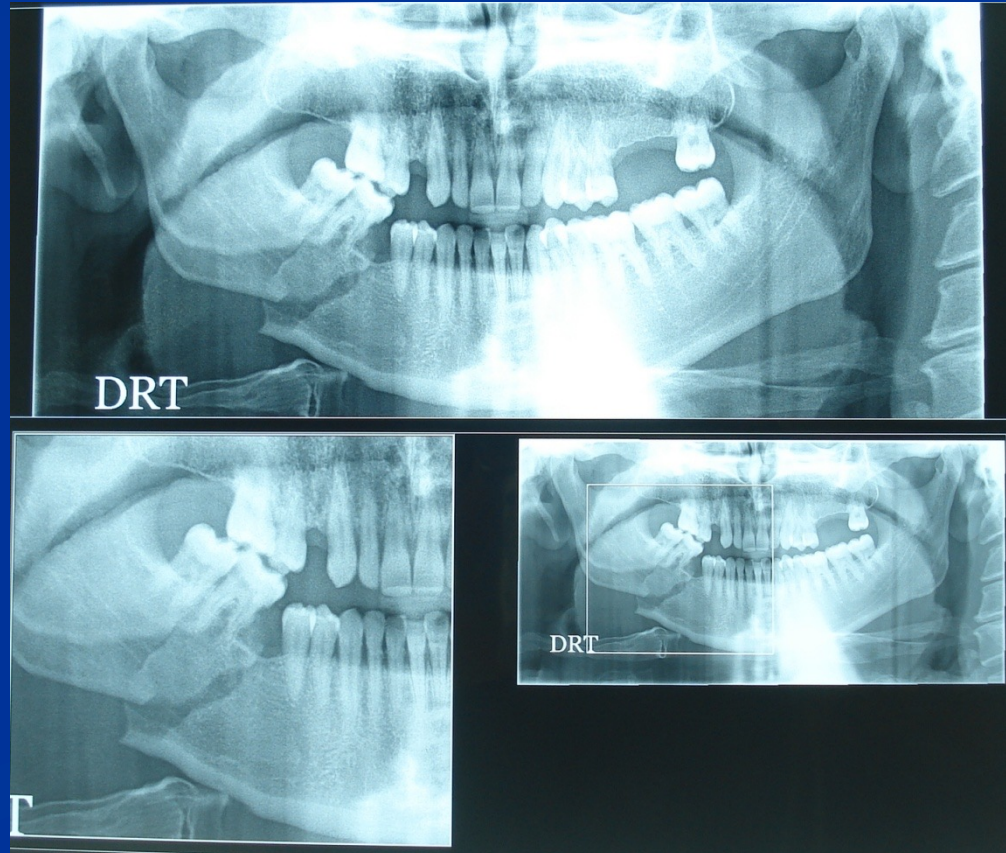


III. BILAN

4) Examens complémentaires

a. Radiographies standards

3. Orthopantomograme



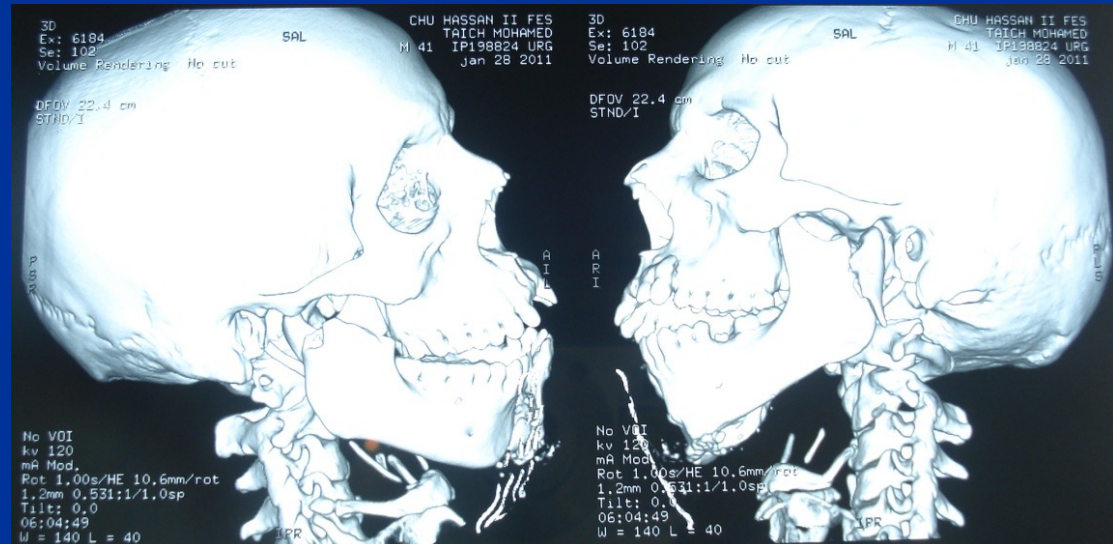
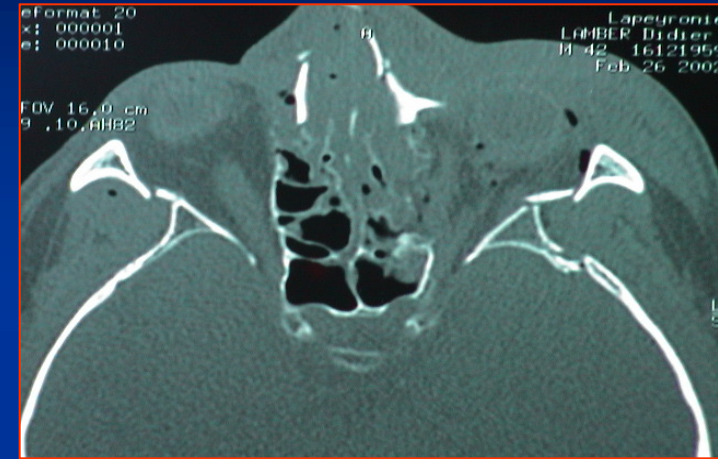
III. BILAN

4) Examens complémentaires

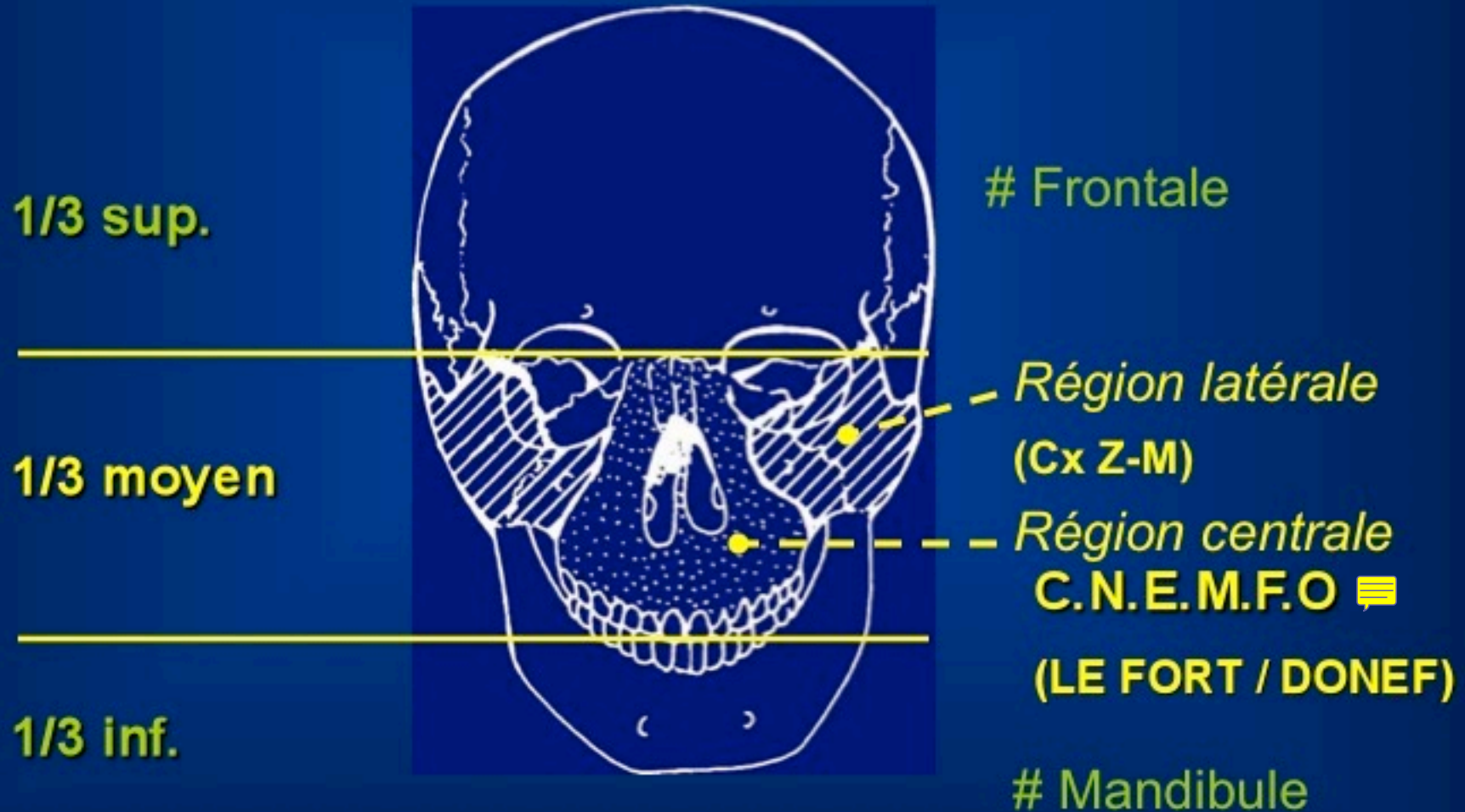
b. TDM

c. IRM

■ Pas d'intérêt en urgence



IV. CLASSIFICATION



IV. CLASSIFICATION

→ Formes topographiques

1. Les traumatismes des tissus mous de la face
2. Les traumatismes dentaires et alvéolaires
3. Les traumatismes osseux de l' étage inférieur de la face
4. Les traumatismes des étages moyen et supérieur de la face

IV. CLASSIFICATION

→ Formes topographiques

1. Les traumatismes des tissus mous de la face
 1. Plaies simples
 2. Morsures
 3. Plaies avec perte de substance
 4. Plaies avec atteinte d'un organe noble



LÉSIONS TÉGUMENTAIRES

Pronostic fonctionnel des plaies orificielles

-> **cicatrices sténosantes**

- Paupières
- Lèvres
- Narines
- Conduit auditif externe



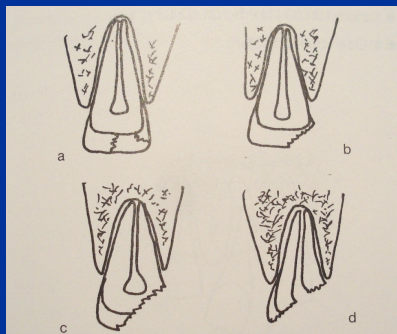
-> suture soigneuse précoce + méchage
(narine, CAE)

IV. CLASSIFICATION

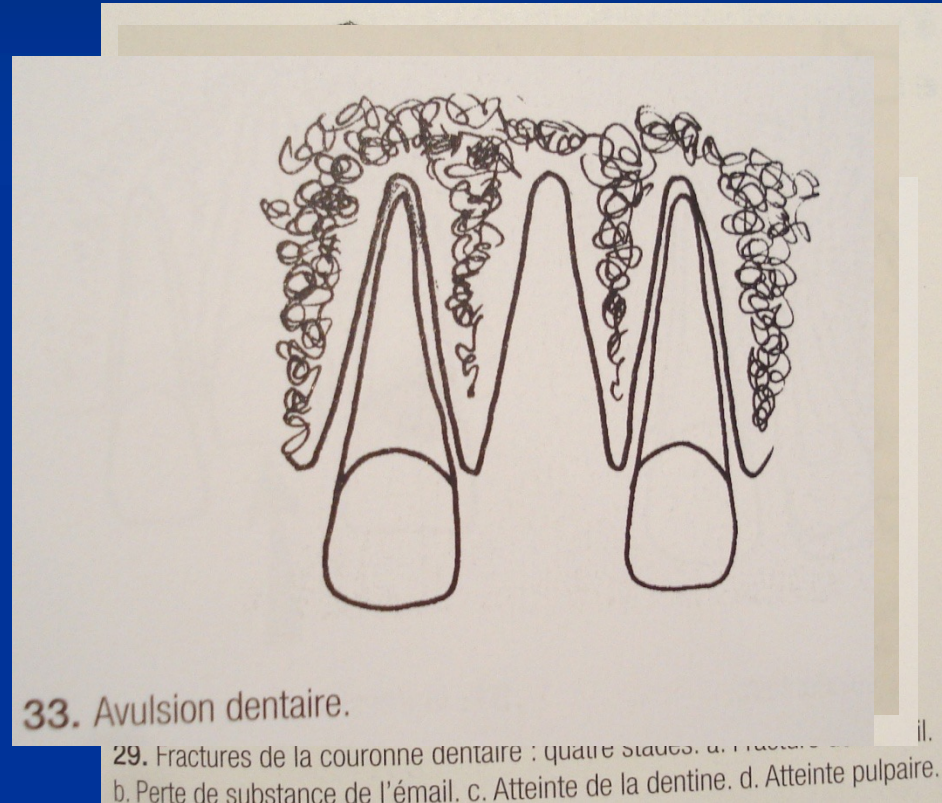
→ Formes topographiques

2. Les traumatismes dentaires et alvéolaires

1. Contusion dentaire
2. Fracture coronaire
3. Fracture avéolo-dentaire
4. Ingression dentaire
5. Subluxation dentaire
6. Avulsion dentaire



29. Fractures de la couronne dentaire : quatre stades. a. Fracture de l'émail. b. Perte de substance de l'émail. c. Atteinte de la dentine. d. Atteinte pulpaire.



33. Avulsion dentaire.

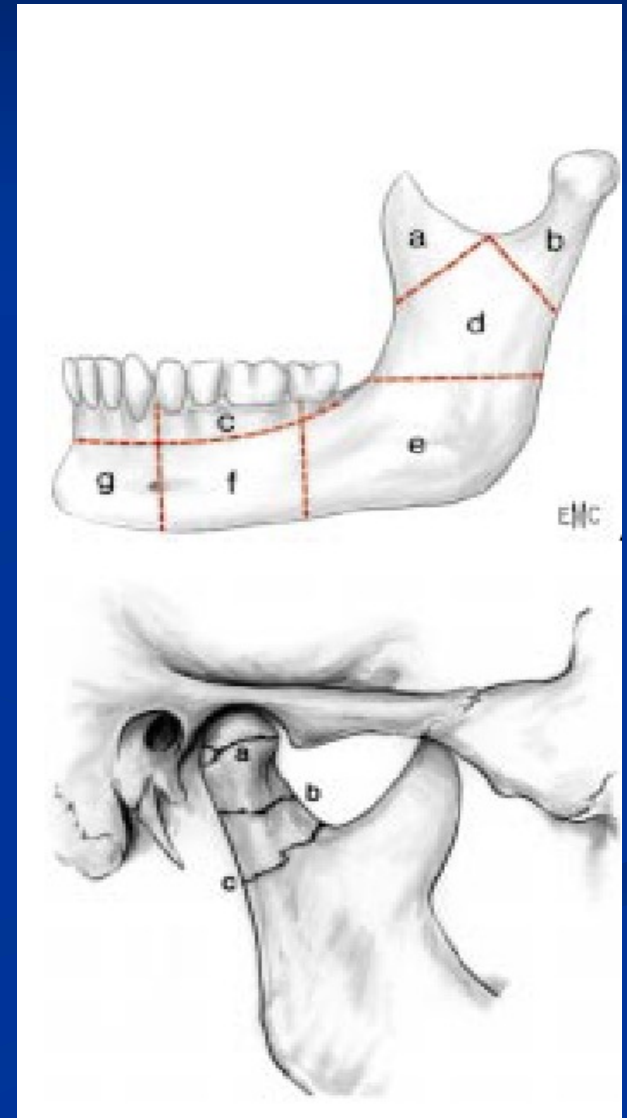
29. Fractures de la couronne dentaire : quatre stades. a. Fracture de l'émail. b. Perte de substance de l'émail. c. Atteinte de la dentine. d. Atteinte pulpaire.

IV. CLASSIFICATION

→ Formes topographiques

3. Les traumatismes osseux de l'étage inférieur de la face

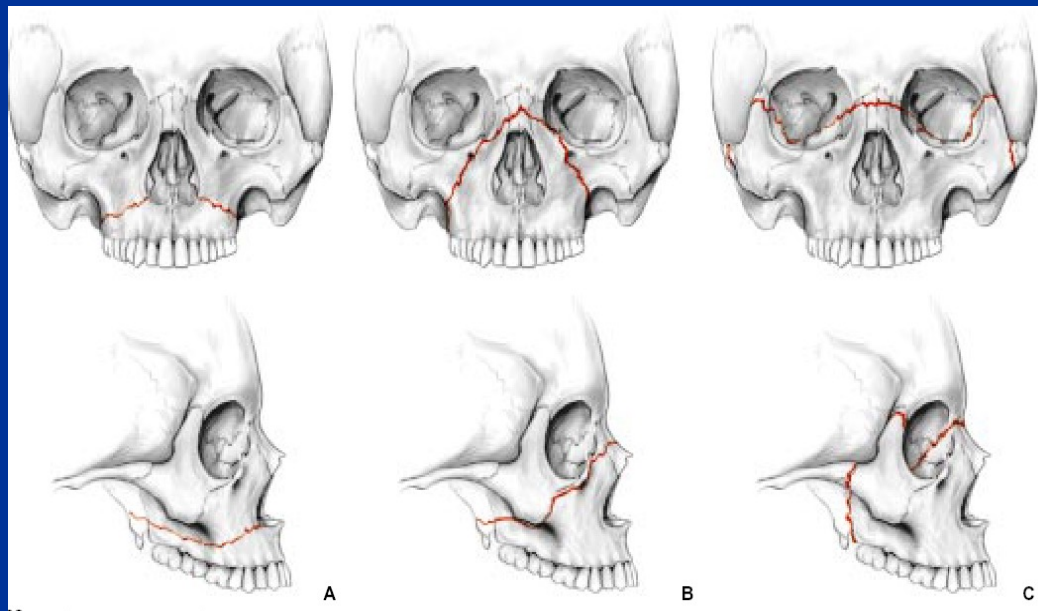
1. Luxations temporo-mandibulaires
2. Fractures mandibulaires



IV. CLASSIFICATION

→ Formes topographiques

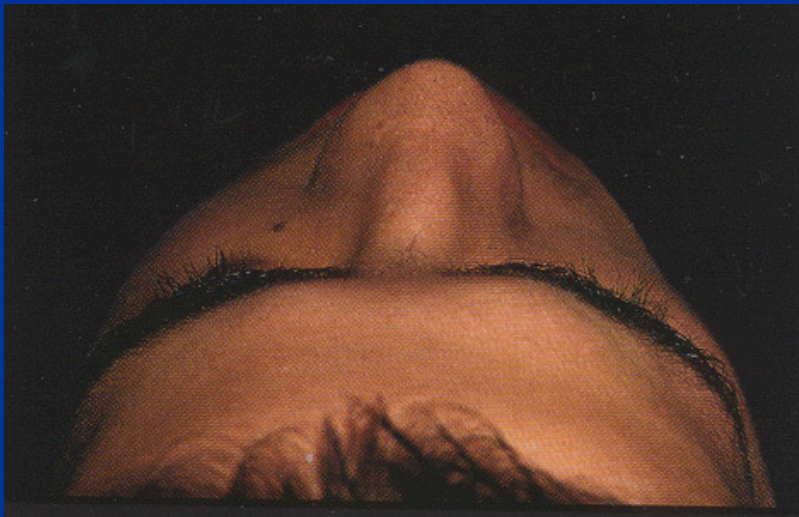
4. Les traumatismes des étages moyen et supérieur de la face
 1. **Disjonctions crânio-faciales**
 2. Traumatisme du tiers latéral de la face
 3. Traumatismes du tiers médian de la face = fractures Centro-faciales



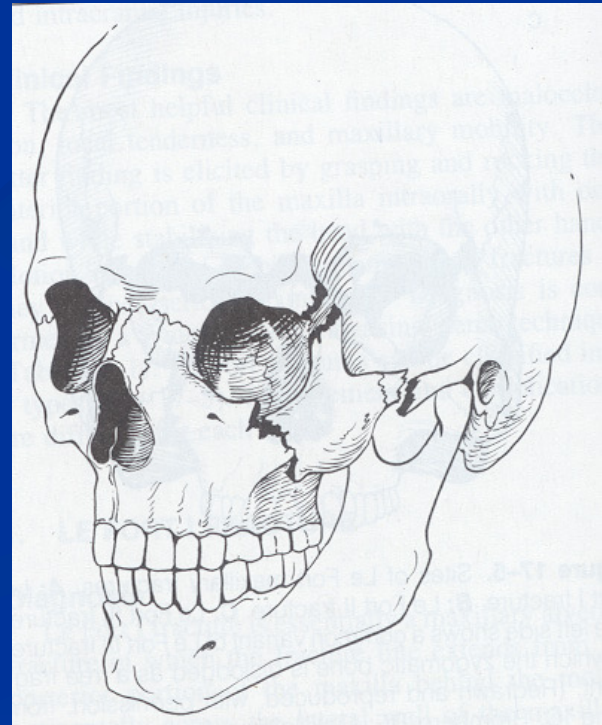
FORMES CLINIQUES

→ Formes topographiques

4. Les traumatismes du massif facial
 1. Fractures occluso-faciales
 2. **Traumatisme du tiers latéral de la face**
 3. Traumatismes du tiers médian de la face = fractures centrofaciales



Fracture disjonction os zygomatique

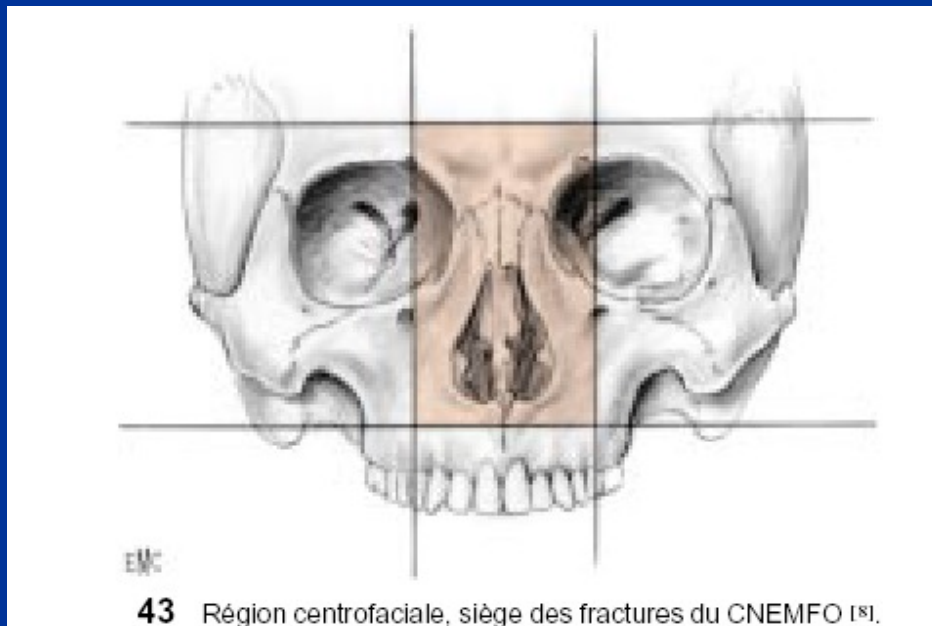


IV. CLASSIFICATION

→ Formes topographiques

4. Les traumatismes des étages moyen et supérieur de la face

1. Fractures occluso-faciales
2. Traumatisme du tiers latéral de la face
3. **Traumatismes du tiers médian de la face = fractures centrofaciales**



V. TRAITEMENT

A. Buts

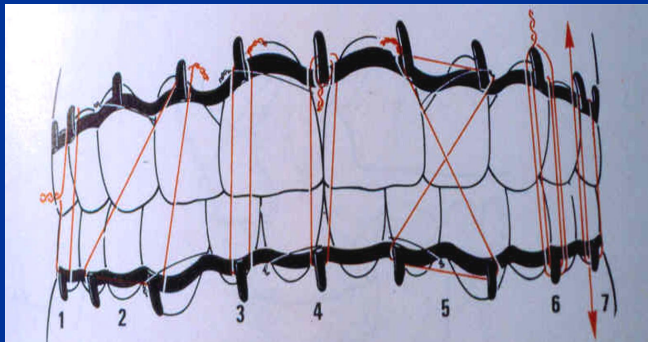
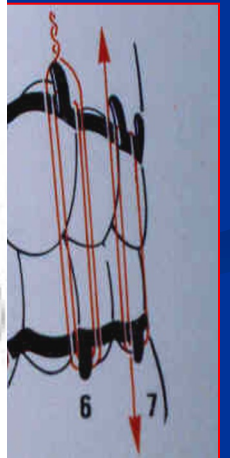
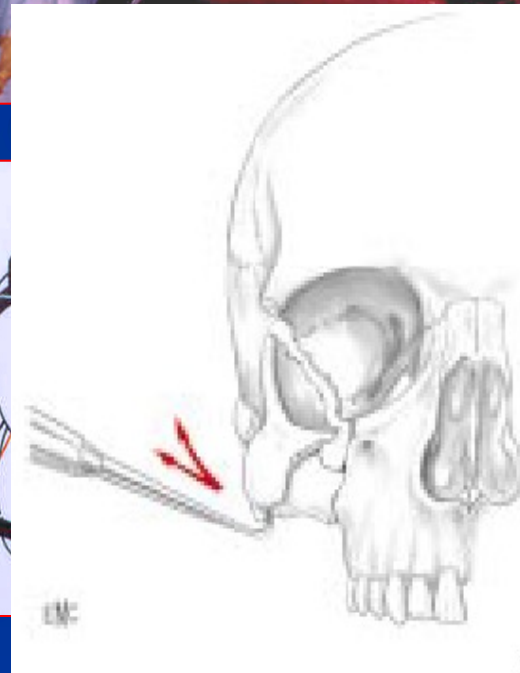
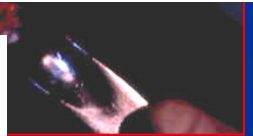
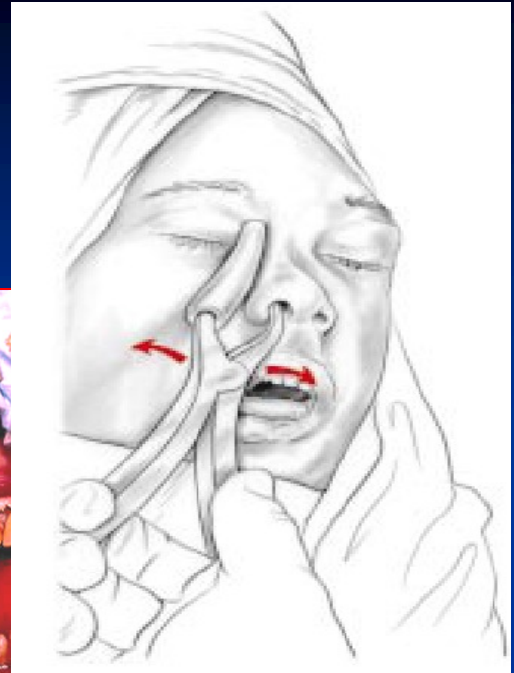
1. L' anatomie et l' esthétique
2. La fonction
3. Éviter les complications et les séquelles

**Règle des quatre T édictée par Jean Pons :
traiter tout, tôt, totalement, en un temps.**

V. TRAITEMENT

B. Moyens

1. Traitements médicaux
2. Réparation osseuse
 - a. Procédés fonctionnels
 - b. Procédés orthopédiques

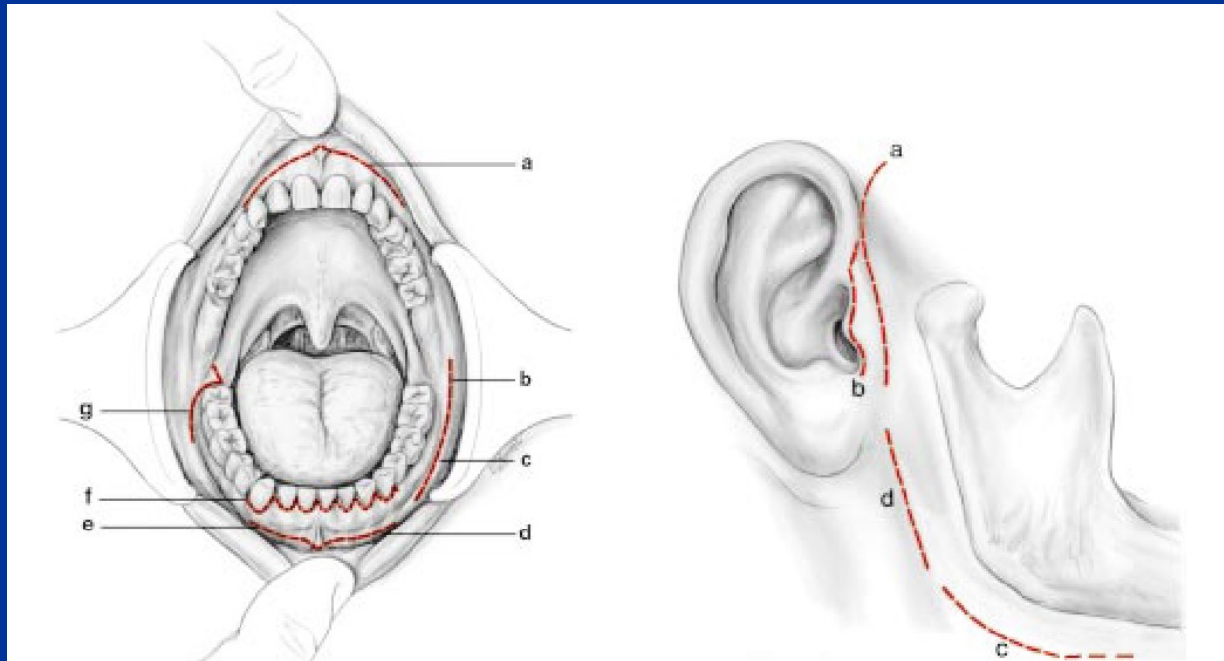


V. TRAITEMENT

B. Moyens

2. Réparation osseuse

c. Procédés chirurgicaux

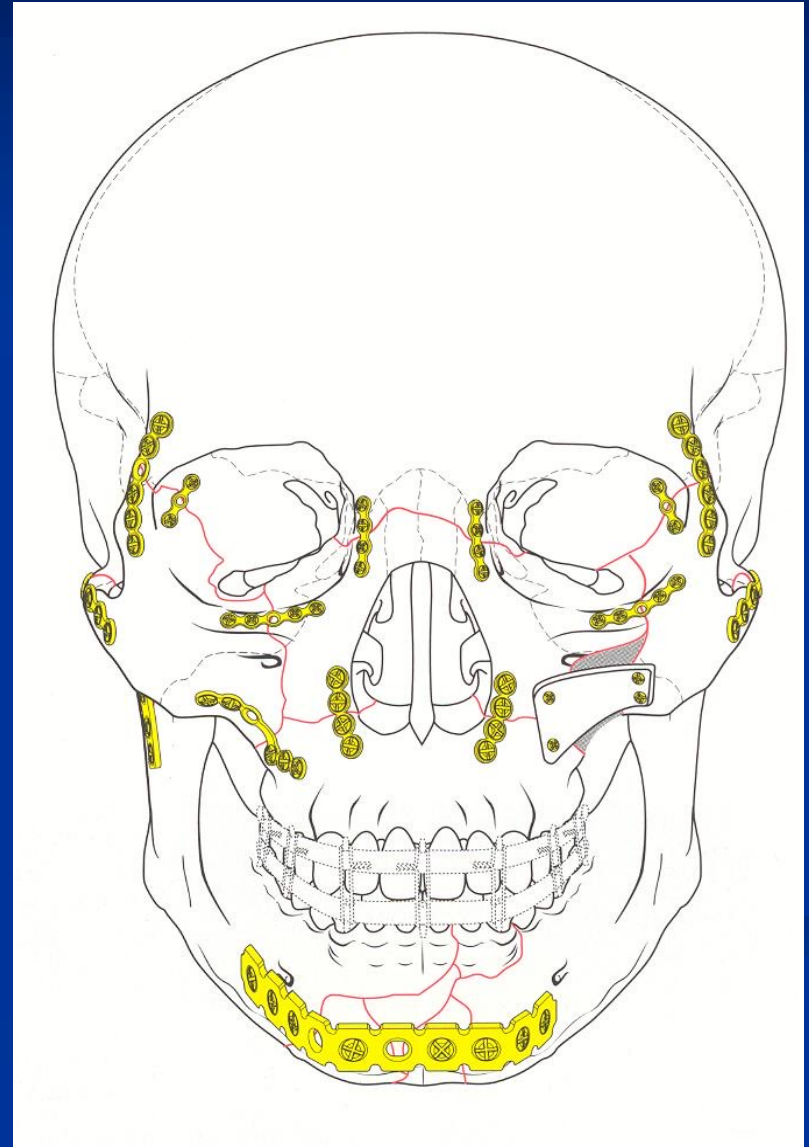


V. TRAITEMENT

B. Moyens

2. Réparation osseuse

c. Procédés chirurgicaux



V. TRAITEMENT

B. Moyens

3. Réparation tégumentaire

- PDS → réparation par lambeau local ou de voisinage
- Lésion du Nerf facial → sutures microchirurgicale du tronc
- Glandes salivaires → parenchyme parotide : compression
- Sténose → suture à l'aide d'un cathéter
- Voies lacrymales : suture sur cathéter laissé en place pendantt 6 mois

V. TRAITEMENT

B. Moyens

3. Réparation tégumentaire

4. Problèmes dentaires

- Dents délabrées, dans trait de fracture, gênant la réduction → extraction
- Dent bien implantée même endommagée → ancrage pour blocage et articulé dentaire
- Hygiène bucco-dentaire → détartrage, soins de caries

VI. CONCLUSION

- Urgences vitales en 1^{er}
- Bilan clinique et paraclinique
- Prise en charge multidisciplinaire
- Traitement précoce, complet
- Séquelles
 - Fonctionnelles → trouble de l'articulé,
paralysie faciale, diplopie, limitation
d'ouverture buccale, épiphora
 - Esthétiques → enophtalmie, télécanthus,
cicatrices disgracieuses